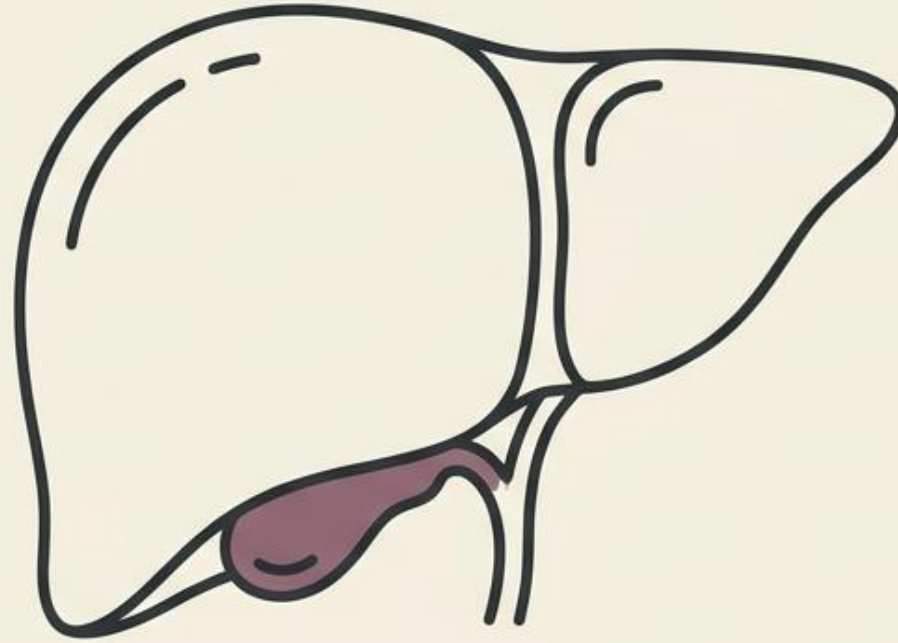


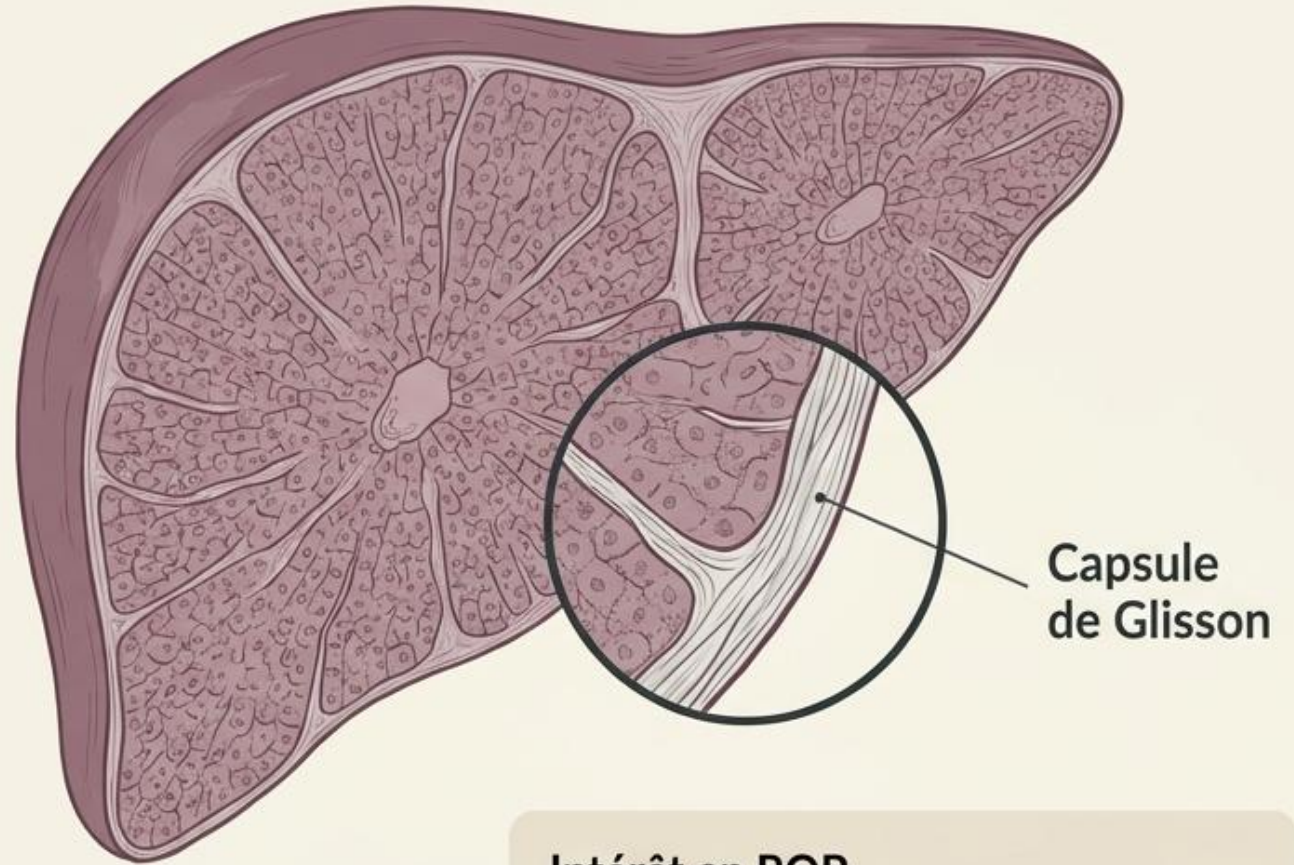


Foie et Voies Biliaires

Anatomie, Physiologie et Approche Clinique ROP

Macro-anatomie et Structure Tissulaire

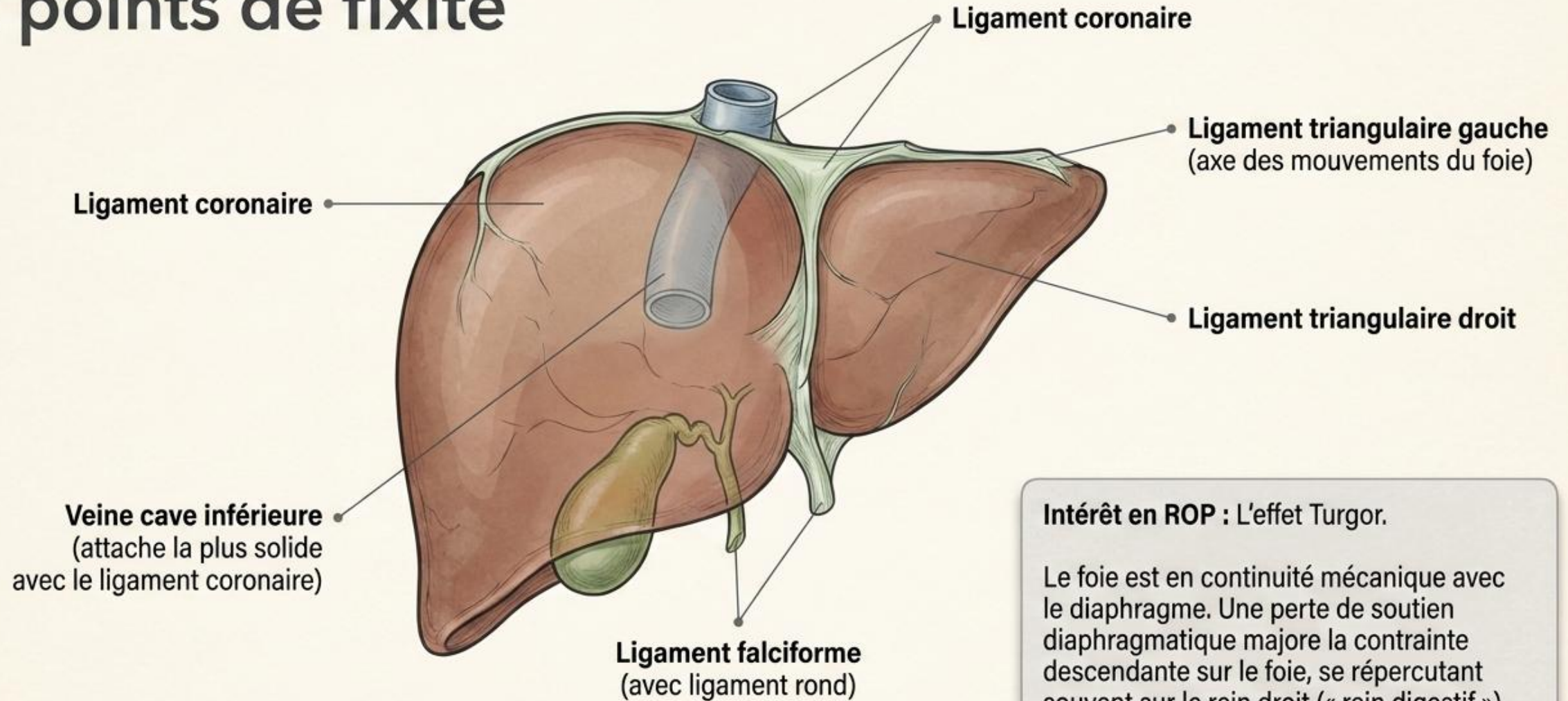
- **Viscère le plus volumineux :**
~2 % du poids corporel.
- **Poids cadavérique :** ~1,5 kg /
Poids in vivo (gorgé de sang) : 2,5 à 3 kg.
- **Débit sanguin :** ~25 % du débit cardiaque.
- **Localisation :**
Intra-péritonéal (tra-péritonéal
(hypocondre droit et épigastre), à
l'exception de l'area nuda.



Intérêt en ROP

La capsule de Glisson offre une armature fibreuse ferme, rendant le foie aisément repérable à la palpation. Sa consistance et sa situation antérieure l'exposent particulièrement aux traumatismes abdominaux.

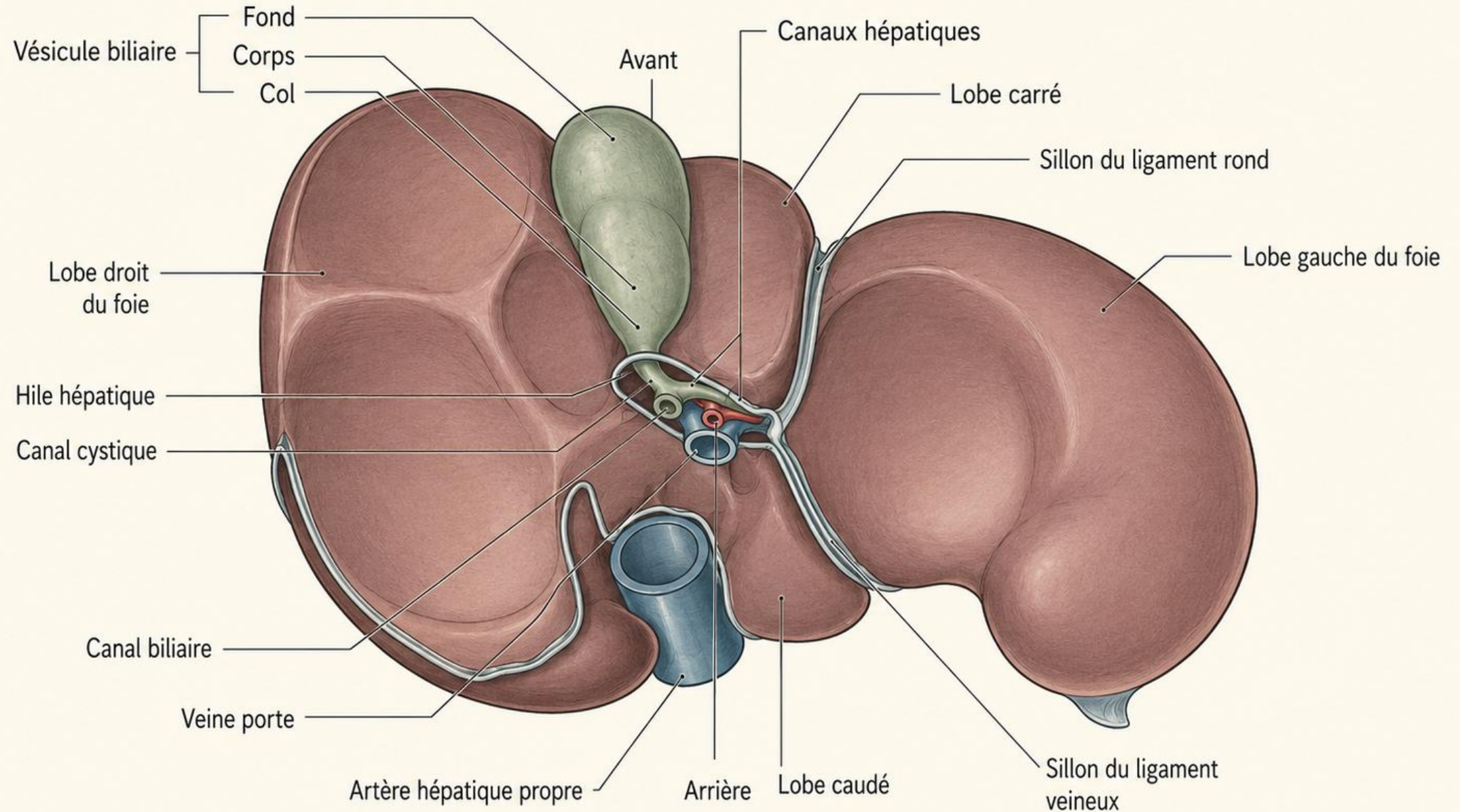
Architecture mécanique et points de fixité



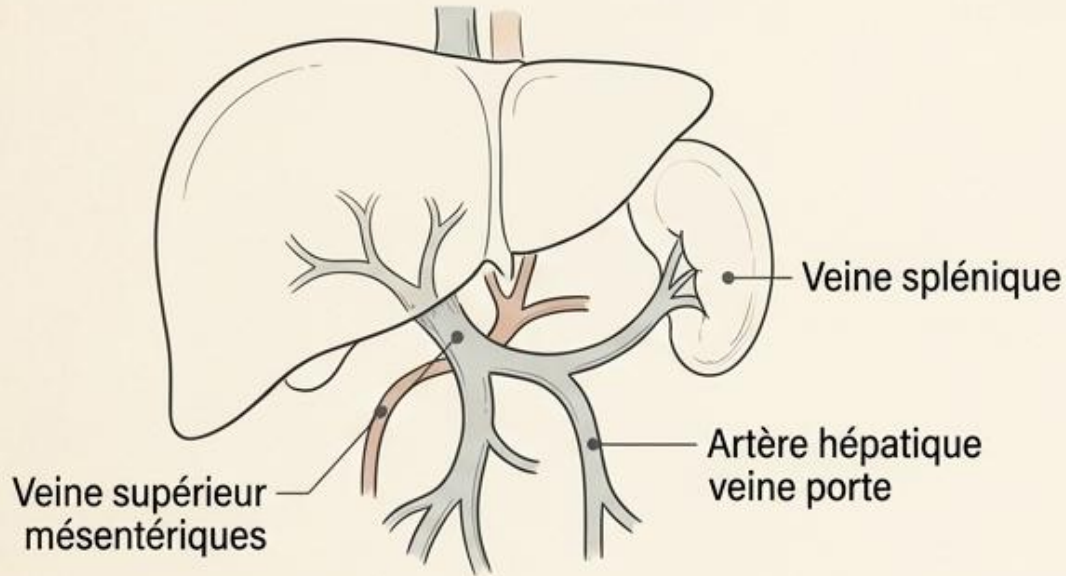
Intérêt en ROP : L'effet Turgor.

Le foie est en continuité mécanique avec le diaphragme. Une perte de soutien diaphragmatique majore la contrainte descendante sur le foie, se répercutant souvent sur le rein droit (« rein digestif »).

Face viscérale du foie



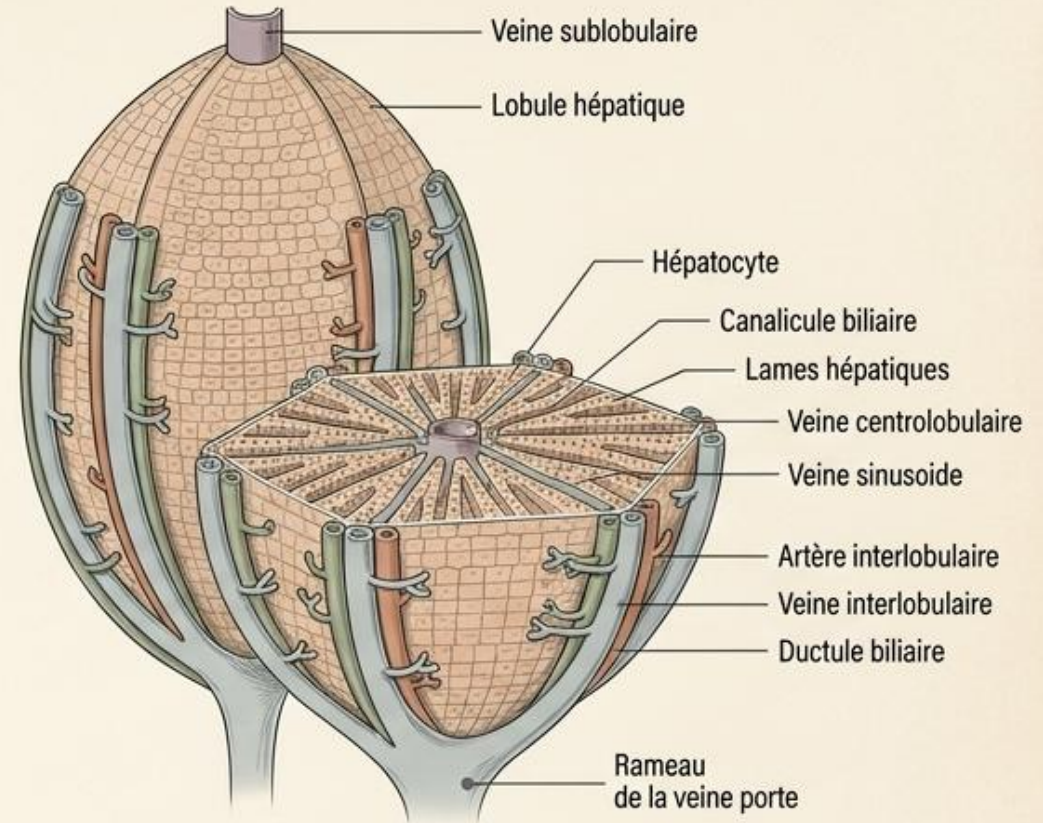
Dynamique vasculaire et l'unité lobulaire



Apport sanguin mixte :

- 75 % veineux (Veine porte, riche en nutriments)
- 25 % artériel (Artère hépatique propre, riche en O₂)

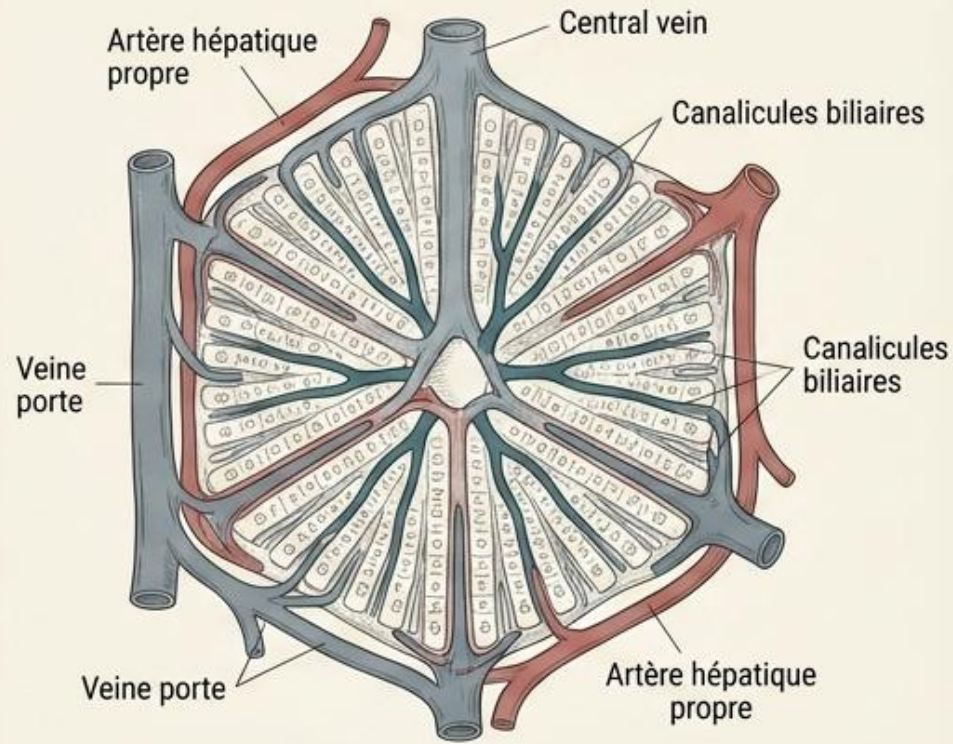
Origine de la veine porte : Réunion des veines splénique et mésentériques (supérieure et inférieure).



Le lobule hépatique :

- Unité fonctionnelle classique du foie.
- Réseau de capillaires sinusoides permettant les échanges entre le sang et les hépatocytes (transformation, détoxification, formation de la bile).
- Drainage via les veines centrolobulaires vers les veines sus-hépatiques.

Le Lobule Hépatique : Carrefour Fluides & Énergies



Vaisseaux afférents

75 % de sang veineux via la Veine porte (chargé de nutriments).

25 % de sang artériel via l'Artère hépatique propre (oxygéné).

L'Échange (Capillaires sinusoides)

Permet la détoxification, la formation de la bile, et la transformation métabolique des nutriments.

Vaisseaux efférents

Le sang quitte l'unité par la veine centrolobulaire → veines sus-hépatiques → veine cave inférieure.

1. Fonction Digestive :

Métabolisme des glucides et acides aminés.

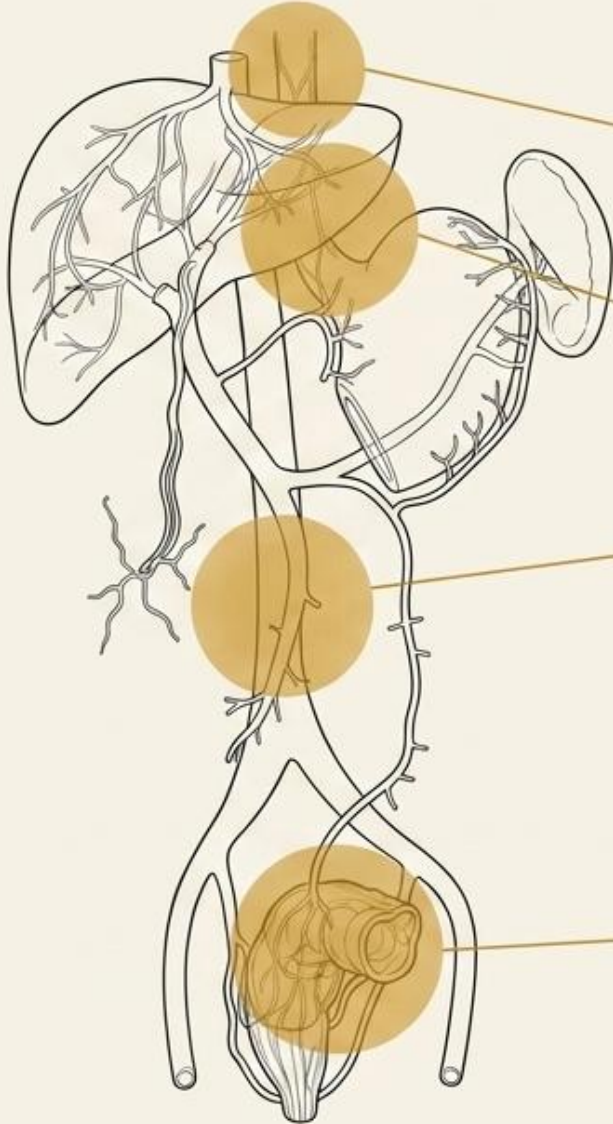
2. Fonction Détoxifiante :

Élimination de l'ammoniac, alcool et toxiques.

3. Fonction Immunitaire :

Action des cellules de Kupffer (phagocytose).

Le Réseau Porte et les Voies de Dérivation



Un obstacle intra-hépatique (perte de souplesse, fibrose) augmente la pression portale. Le sang dérive alors vers le système cave via des anastomoses.

Zones de dérivation (Anastomoses porto-caves) :

- Œsophagiennes (Varices)
- Région ombilicale ("Tête de méduse")
- Région ano-rectale (Hémorroïdes)

Intérêt en ROP : Les traumatismes, la position assise prolongée ou les séquelles d'hépatite créent une gêne porto-hépatique fonctionnelle. Restaurer la souplesse conjonctive hépatique soulage ce retour veineux.

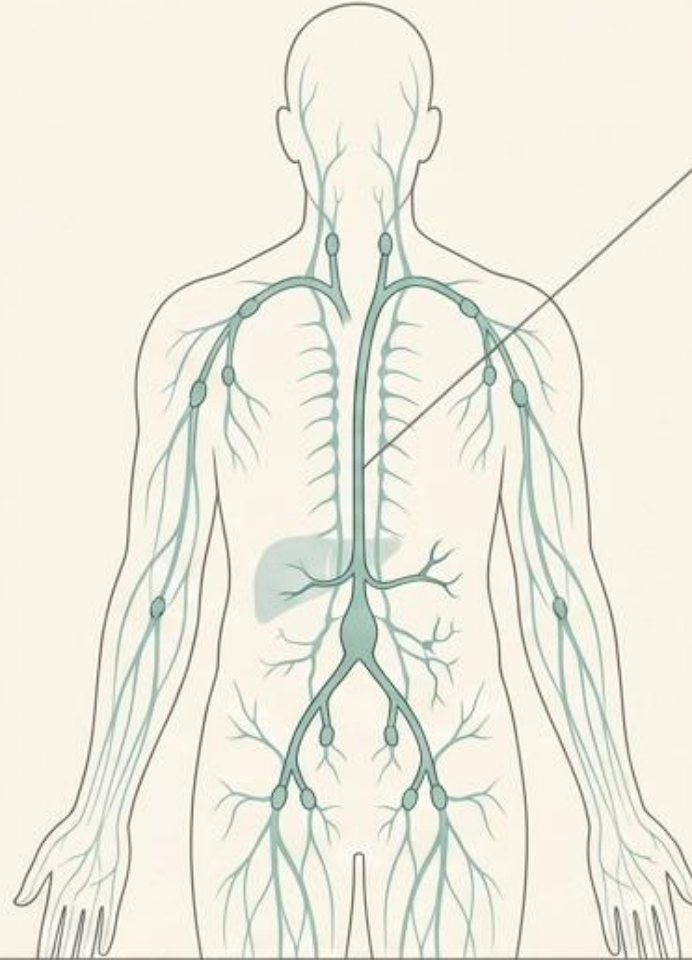
Dynamique des fluides et congestion

Hypertension Portale

Les obstacles fibrotiques ou la congestion hépatique augmentent la pression portale.

Voies d'échappement systémiques (anastomoses) :

- Varices œsophagiennes
- Hémorroïdes
- Réseau para-ombilical
- Réseau rachidien



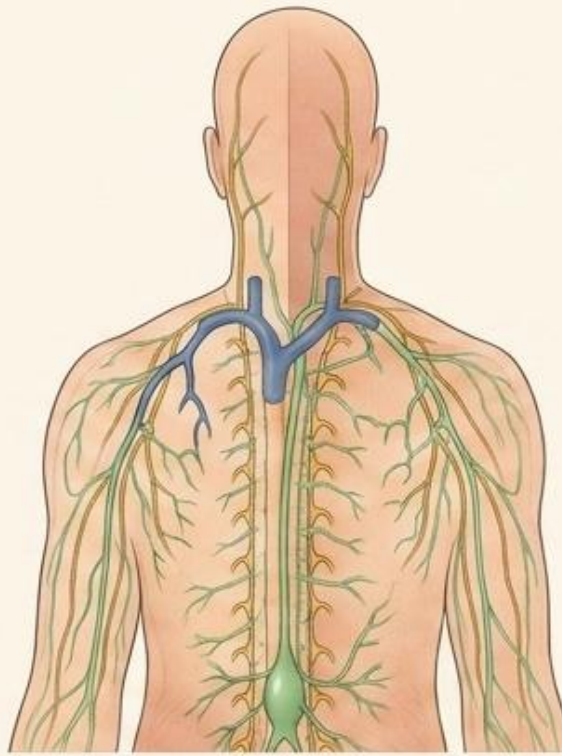
Réseau Lymphatique

Le foie produit environ 1L de lymphes par jour.

Le réseau profond se draine vers la Citerne de Chyle et le conduit thoracique.

Note ROP : Le traitement du foie nécessite l'intégration des reins et du système lymphatique pour lever la stase.

Circulation Lymphatique et Drainage



Le Réseau Superficiel

- Accompagne les veines sus-hépatiques et la VCI.
- Rejoint la Grande veine lymphatique.
- Drainage final : Veine subclavière droite.

Le Réseau Profond

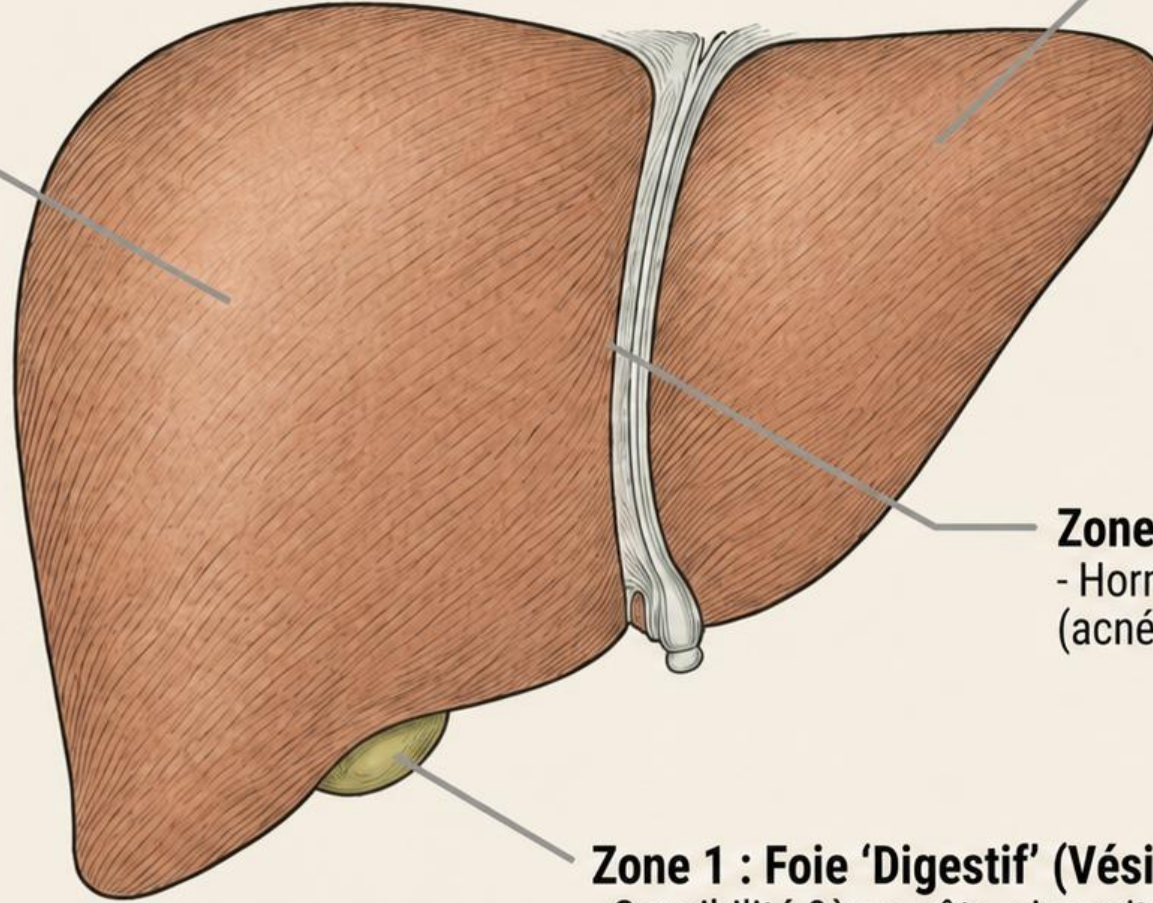
- Collecte la lymphe du parenchyme hépatique (~1L/jour) via le petit omentum.
- Rejoint la Citerne de chyle de Pecquet.
- Drainage final : Conduit thoracique (Veine subclavière gauche).

Axe Thérapeutique ROP : Le traitement d'un foie engorgé nécessite impérativement le soutien des reins et du système lymphatique global.

Les 4 Segments Fonctionnels

Zone 3 : Foie 'Infectieux/Immunitaire' (Lobe droit massif)

- Sollicité post-gastro-entérite
(fatigue persistante), hépatites.



Zone 4 : Foie 'Mécanique' (Lobe gauche)

- Réceptacle des forces de
collision/traumatismes.
Douleurs Th7-Th9, sciatalgie droite.

Zone 2 : Foie 'Métabolique' (Épigastre)

- Hormono-dépendant. Troubles cutanés
(acné, prurit), états inflammatoires.

Zone 1 : Foie 'Digestif' (Vésicule)

- Sensibilité 9ème côte, viscosité biliaire.
Projections C4-C5 gauches puis droites.

Physiologie Globale : Les 4 Piliers Fonctionnels



Digestive & Métabolique

Transformation des glucides/acides aminés. Sécrétion de bile (pH 7.6-8.6) et sels biliaires pour l'émulsion des lipides.



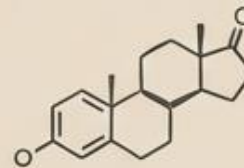
Détoxifiante

Transformation et élimination de l'ammoniac, alcools, médicaments, et toxiques environnementaux.



Immunitaire

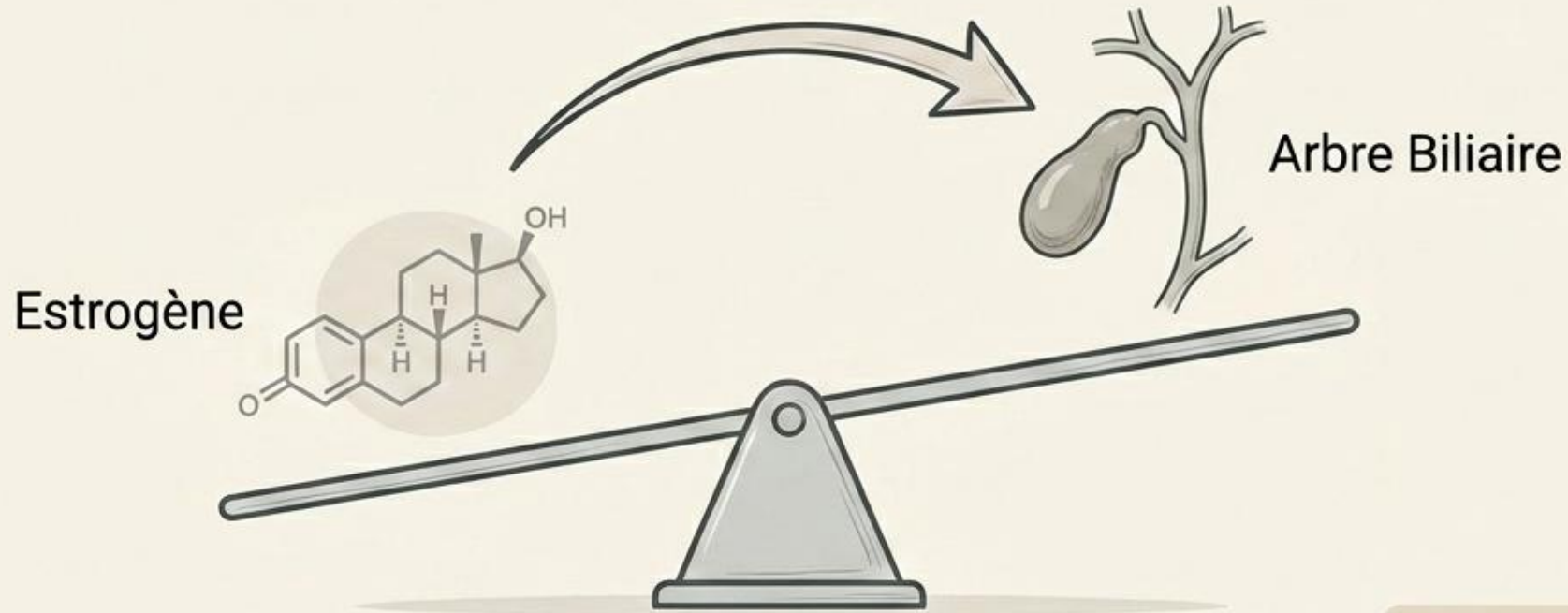
Filtrage du sang via les cellules de Kupffer. Phagocytose des hématies âgées issues de la rate.



Hormonale

Métabolisme des œstrogènes et progestérone. Note : Un excès d'œstrogènes (pilule, grossesse) épaissit la bile, favorisant nausées et stase.

Mécanique Hormono-Biliaire



1. Déclencheur :
État d'hyperœstrogénie
(grossesse 6e-8e mois, prise
de pilule contraceptive, cycle
préménstruel, ménopause).

2. Processus :
Augmentation significative
de la saturation de la bile
en cholestérol.

3. Conséquence :
La bile devient plus épaisse,
créant une stase biliaire,
favorisant la boue biliaire ou
l'apparition de
micro-lithiases.

Intérêt en ROP

Le foie est « hormono-dépendant »
sur le plan fonctionnel. Ces
surcharges hépatiques
s'accompagnent fréquemment de
projections neurologiques
(cervicalgies, péri-arthrites scapulo-
humérales droites), typiquement
observées à la ménopause.

Matrice diagnostique clinique

	Foie	Vésicule Biliaire
DRAPEAUX ROUGES (EXCLUSION)	Douleurs nocturnes hypochondre droit, fièvre, amaigrissement, hépatomégalie, ascite.	Cholécystite aiguë, coliques hépatiques.
SYMPTÔMES DIGESTIFS	Lenteur digestive, langue saburrale, haleine acétonique, urines foncées, fatigue matinale.	Pesanteur post-prandiale immédiate, intolérance absolue aux graisses.
SYMPTÔMES NON-DIGESTIFS	Syndrome Global Photophobie, transpiration à l'effort, prurit, cervicalgie au réveil, douleur rétro-scapulaire droite, états dépressifs et cyclothymiques.	

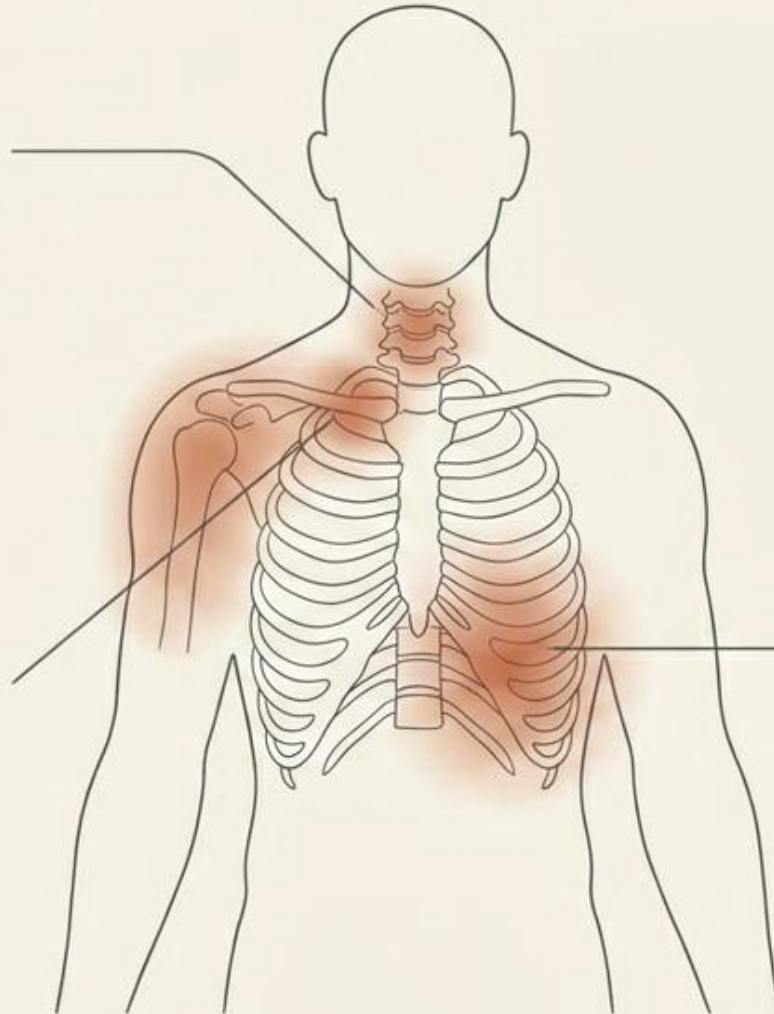
Cartographie des projections viscéro-somatiques

C5-C6 & Épaule Droite

Tension transmise via le nerf phrénique et le plexus brachial. Souvent lié aux fragilisations hormonales (ménopause).

Défilé Thoracique

Continuités neuro-musculaires et fasciales profondes (Capsule de Glisson -> diaphragme -> plèvre -> ceinture scapulaire).



Th7 à Th9 & Côtes 7-8

Zones vertébrales et costales en souffrance réflexe, caractéristique du foie dit "mécanique".

Profils viscéro-émotionnels



Le Profil Foie

L'Identité et le Passé

Organe lié au stress profond de l'identité et aux culpabilités familiales. Exprime une colère sourde dirigée vers soi ou les autres. Le profil est souvent souvent prisonnier de la routine, sujet au ressassement et à l'épuisement psychique ("cerveau manquant d'énergie"). Développe une susceptibilité marquée par insécurité.



Le Profil Vésicule

L'Anxiété et le Quotidien

Organe de la contrariété et de l'insatisfaction permanente. Souci matériel constant activant le système sympathique. Hypersensibilité exacerbée ("nerfs à fleur de peau"). Montre un besoin absolu de repères fixes, développant une intolérance sévère aux changements d'habitudes et aux séparations.

Synthèse clinique et hygiène de vie



La Balance Écoute-Induction :

Un pouce sur le foie/vésicule biliaire, l'autre sur le cerveau limbique pour induire le calme intellectuel et l'intégration émotionnelle.

Exclusions et Modérations Alimentaires

À exclure strictement :

- Sulfites (vins, bières, plats cuisinés)
- Conservateurs E222 à E227 (hautement défavorables)
- Graisses animales cuites et fritures

À modérer fortement :

- Chocolat
- Fruits de mer
- Pâtisseries industrielles